

ECR 状态对比报告

生成时间：2026-05-29 19:29:14

ECR 状态对比报告

一、住院前状态摘要

陈萍忠老人确诊阿尔茨海默病性痴呆4年余，长期存在行为与精神症状（BPSD），近期症状显著加重，表现为拒绝进食、拒绝配合康复训练、不愿与人交流及情绪躁动。NPI评分为22分。既往有心脏起搏器植入术及胆囊切除术史，血压、血脂控制不佳，未规律服药。日常生活能力方面，可独立完成进食与穿衣，平地行走需部分辅助，洗澡需他人协助。家属因长期照护压力大，存在明显照护焦虑，且缺乏专业照护知识。此次因BPSD急性加重急诊入院，入院时情绪躁动，但生命体征基本平稳。

二、出院时状态摘要

经住院治疗，老人BPSD症状明显缓解，NPI评分降至16分，情绪趋于平稳，可配合基础照护操作。生命体征稳定，心率维持在60次/分，睡眠与饮食恢复规律。医嘱要求规律服用降压及调脂药物，并每日监测血压。日常生活能力较住院前无明显变化，仍可独立进食穿衣，平地行走需部分辅助。当前照护重点明确为：跌倒防护、规律服药管理、认知非药物干预、BPSD症状持续监测及家属心理与技能支持。

三、ADL变化

无明显变化。住院前后均保持独立进食、穿衣能力，平地行走需部分辅助，洗澡需他人协助。

四、NPI变化

显著改善。NPI评分由住院前的22分降至出院时的16分，提示行为与精神症状整体减轻。

五、进食状态变化

显著改善。住院前存在明确拒绝进食行为，出院时饮食已恢复规律，配合度良好。

六、睡眠状态变化

改善。住院前虽未直接描述睡眠障碍，但BPSD加重常伴睡眠紊乱；出院时明确记录“睡眠规律”，提示睡眠质量提升。

七、吞咽风险变化

（留空）

八、关键退化项

无。本次住院为BPSD急性发作所致，非认知或躯体功能进行性退化；出院时未见新发功能退化表现。

九、新增风险点

1. ****用药依从性风险****：既往未规律服药，出院后需严格遵医嘱服药，依从性成为新发管理重点。
2. ****潜在心动过缓风险****：心率持续维持在60次/分（正常偏低），结合心脏起搏器病史，需警惕心律异常。

十、重点观察项

- BPSD症状是否复发或波动
- 血压、血脂控制效果及药物不良反应
- 跌倒风险（尤其在行走及洗澡过程中）
- 服药依从性与实际执行情况
- 情绪稳定性及照护配合度变化

十一、承接建议级别

建议定为****中高照护需求级别****。老人虽BPSD缓解，但仍存在慢性疾病管理、跌倒防护、认知干预及家属支持等多重照护需求，需机构提供结构化、专业化照护方案。

十二、既往行为模式对比

住院前呈现典型的“抗拒型